

Trouble psychotique induit par un médicament

 De nombreux médicaments prescrits pour des problèmes de santé non psychiatriques peuvent induire l'apparition de symptômes psychotiques (hallucinations, idées délirantes) chez des personnes ne présentant pas de trouble psychotique.

 Les troubles psychotiques induits par des médicaments :

- ☞ apparaissent en général dans les jours suivant l'introduction d'un nouveau traitement chez des personnes sans antécédent psychiatrique connu
- ☞ sont des effets indésirables liés aux propriétés pharmacologiques de ces médicaments : une augmentation de la transmission dopaminergique est le mécanisme le plus souvent impliqué
- ☞ régressent en général rapidement après l'arrêt du traitement ou la réduction des doses, quand les effets pharmacologiques du traitement disparaissent ou s'atténuent
- ☞ peuvent nécessiter un traitement antipsychotique, notamment si le médicament en cause ne peut pas être arrêté ou diminué

 Hormis leur apparition brutale, les symptômes psychotiques induits par des médicaments ont peu de caractéristique spécifique :

- ☞ ils peuvent être associés à des symptômes maniaques ou dépressifs
 - ☞ des hallucinations visuelles orientent vers une cause somatique non psychiatrique
 - ☞ des symptômes de confusion sont surtout observés chez les personnes âgées
- ⚠ le risque suicidaire doit être systématiquement évalué

 La liste des médicaments non psychotropes pouvant induire des symptômes psychotiques est longue, les plus à risque sont (liste non exhaustive) :

- ☞ corticoïdes : surtout en début de traitement à hautes doses (> 40 mg/jour de prednisolone)
- ☞ anti-parkinsoniens : très fréquent chez les usagers d'agonistes dopaminergiques (20%-50%), aussi avec les anticholinergiques
- ☞ antipaludéens : surtout méfloquine, plus rarement chloroquine
- ☞ antituberculeux: l'isoniazide inhibe la monoamine oxydase (IMAO), ses effets antidépresseurs ont été très vite identifiés dans les sanatorium ; des symptômes psychotiques peuvent être associés aux symptômes (hypo)maniaques
- ☞ antibiotiques : fluoroquinolones comme la ciprofloxacine, métronidazole, etc.
- ☞ immuno-modulateurs/suppresseurs : interferon-alpha, cyclosporine

? Comme pour tous les troubles psychotiques induits par des causes somatiques non psychiatriques, se pose la question d'une vulnérabilité préexistante révélée par l'exposition au médicament. Il n'y a jamais de réponse simple à cette question. Un effet essentiellement imputable au médicament est le plus plausible

- ☞ si les symptômes régressent rapidement
- ☞ en l'absence d'antécédents personnel ou familiaux de trouble psychiatrique.

! Pour une personne avec un trouble psychotique (ou bipolaire), la prescription de ces traitements reste en général possible. Une surveillance accrue de l'état psychique est recommandée, et une adaptation des traitements psychotropes peut être nécessaire le temps du traitement.

Références

<https://doi.org/10.1007/s00228-024-03738-x>

<https://doi.org/10.3390/diseases12120300>

Trouble psychotique induit par un médicament

